



Bác sĩ Chúc

SỨC KHOẺ · TRƯỜNG THỌ

★ TẶNG MIỄN PHÍ

CẨM NANG SỨC KHOẺ 2026

30 Dấu Hiệu Mắt Cơ

Nhận biết sớm — Giữ sức mạnh sau tuổi 40



Bác sĩ Nguyễn Xuân Chúc

15 năm kinh nghiệm · Bác sĩ chạy Ironman

drchuc.com



Bác sĩ Chúc

SỨC KHOẺ · TRƯỜNG THỌ

• CẨM NANG SỨC KHOẺ 2026

30 Dấu Hiệu Mất Cơ

Nhận biết sớm – Giữ sức mạnh sau tuổi 40

Tự kiểm tại nhà, biết khi nào cần đi khám và kế hoạch giữ cơ 12 tuần – theo AWGS 2025, EWGSOP2, ESPEN & WHO, chỉnh lý cho người Việt.

• Tự kiểm 5 phút tại nhà

• 30 dấu hiệu · 5 nhóm

• Kế hoạch giữ cơ 12 tuần

• Biểu mẫu in & dùng ngay



GỬI BẠN ĐỌC

Mất cơ – sự thu hẹp âm thầm của tuổi tác

Một người đàn ông 62 tuổi vẫn tự lái xe, vẫn đi cà phê mỗi sáng. Nhưng gia đình nhận ra ông luôn tìm thang máy – dù chỉ lên một tầng. Hôm tòa nhà mất điện, ông đứng trước cầu thang rất lâu rồi nói: “*Hay hôm nay mình về?*”. Mới vài bậc, hai chân đã nặng trĩu.

Điều đáng nói không phải một lần ông mệt, mà là **việc trước đây làm tự nhiên nay đã thành thử thách**. Đó là cách mất cơ xuất hiện: không ồn ào, nhưng âm thầm làm cuộc sống nhỏ lại – đi ít hơn, ngại ra ngoài, rồi dần phụ thuộc người khác.

Tin tốt: **cơ bắp có thể phục hồi ở nhiều độ tuổi**. Phát hiện sớm, tập đúng, ăn đủ và xử lý bệnh nền có thể giữ lại sức mạnh và sự tự lập. Cuốn cẩm nang này giúp bạn – và cha mẹ bạn – bắt đầu ngay hôm nay.

MỤC LỤC

TÁC GIẢ	Về Bác sĩ Nguyễn Xuân Chúc	03
PHẦN 1	Hiểu đúng về mất cơ	04
PHẦN 2	30 dấu hiệu mất cơ (5 nhóm)	05
PHẦN 3	Tự kiểm tra tại nhà trong 5 phút	10
PHẦN 4-5	Khi nào đi khám & dấu hiệu đỏ	11
PHẦN 6	Kế hoạch giữ cơ 12 tuần	12
PHẦN 7	Biểu mẫu in & dùng tại nhà	13
ĐỒNG HÀNH	Bước tiếp theo cùng Bác sĩ Chúc	14
PHỤ LỤC	Chuyên môn & Tài liệu tham khảo	15

NGƯỜI ĐỒNG HÀNH

Bác sĩ Nguyễn Xuân Chúc



Bác sĩ Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ, hơn **15 năm trong y khoa**, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. Những năm gần đây dành tâm huyết cho **Y học chống lão hóa (Longevity)** – sống khỏe, sống chất lượng sau tuổi 40.

Tôi đến với chủ đề cơ bắp không chỉ từ phòng khám, mà từ chính đôi chân mình – một người chạy Marathon và hoàn thành Ironman. Tôi hiểu rất rõ: **sức mạnh cơ bắp là tài sản phải xây mỗi ngày.**



Ironman 70.3 Đà Nẵng 2026



Aquaman Hạ Long 2026



Full Marathon 42km
×2 giải



Half Marathon 21km
VPBank



Triết lý: “Bác sĩ không chỉ nói về sức khỏe. Bác sĩ phải sống với sức khỏe mỗi ngày.” – Giữ được sức cơ là giữ được quyền tự đứng lên, tự bước đi và tự quyết định cuộc sống của mình.



Hồ sơ đầy đủ tại drchuc.com/ve-bac-si-chuc. Cẩm nang này tổng hợp các đồng thuận quốc tế, ưu tiên AWGS 2025 do phù hợp với người châu Á.

NỀN TẢNG

Hiểu đúng về mất cơ

“Mất cơ” là khi khối lượng và/hoặc sức mạnh cơ giảm dần. Khi đủ nặng và được xác nhận bằng đo lường, y học gọi là **sarcopenia**. Có 3 điều người 40+ nên hiểu.



① Sau 40, cơ “rò rỉ”

Mỗi năm cơ thể mất dần cơ nếu thiếu vận động kháng lực và thiếu đạm. Tự nhiên – nhưng làm chậm được.



② Sức mạnh “đi” trước

Bạn thấy yếu hơn, đứng dậy khó hơn từ lâu **trước khi** nhìn thấy cơ nhỏ lại. Đừng chờ “trông gầy”.



③ Không gầy vẫn thiếu cơ

Bụng to, cân nặng bình thường vẫn có thể mất cơ – mỡ che lấp phần cơ hao hụt (“béo phì mất cơ”).

Ba màu tín hiệu dùng trong sách

- ● Dấu hiệu mạnh / đo được – nên kiểm tra sớm
- ● Đáng chú ý – nên để ý & hỏi bác sĩ
- ○ Gợi ý – nhiều bệnh khác cũng gây ra



4 điều cốt lõi: ① Mất cơ có thể bắt đầu từ tuổi trung niên. ② Sức mạnh giảm trước khi thấy cơ teo. ③ Một dấu hiệu đơn lẻ không đủ kết luận – cần đo & tìm nguyên nhân. ④ Phát hiện sớm thì cứu được.

Ai nên đặc biệt chú ý?



Người **≥65 tuổi**, nhất là khi có té ngã, sụt cân, bắp chân nhỏ.



Người vừa **nằm viện, phẫu thuật, ốm nặng** hoặc nằm giường lâu.



Người **50–64 tuổi** thấy sức khỏe, sức bền giảm.



Người có **suy tim, COPD, tiểu đường, bệnh thận, ung thư**.

ĐỌC CƠ THỂ BẠN

30 dấu hiệu mất cơ

Đừng đếm số dấu hiệu để tự chẩn đoán – hãy dùng chúng để quyết định **có nên đi kiểm tra hay không**. Chỉ một dấu hiệu  cũng đủ là lý do tốt.

NHÓM A · TAY & SỨC BỀN

01

Thấy người yếu đi rõ trong 6–12 tháng

“Việc này trước làm bình thường, giờ thấy đuối hẳn”, dù không đau ở đâu rõ.

→ So với chính mình trong quá khứ. Ảnh hưởng sinh hoạt thì đi kiểm tra; yếu đột ngột → khám ngay.

02

Lực bàn tay yếu đi

Khó mở nắp chai, vặn khóa, bóp kìm, cầm chảo; bắt tay yếu hơn xưa.

→ Thước đo sức mạnh tin cậy nhất – nên đo lực bóp tay khi đi khám.

03

Hay làm rơi đồ, cầm vật không chắc

Cốc, túi đồ dễ tuột tay; phải dùng hai tay cho thứ trước cầm một tay.

→ Yếu nhanh hoặc chỉ một bên kèm tê bì → ưu tiên khám thần kinh.

04

Xách đồ đi chợ, bình nước nặng hơn trước

Phải chia nhỏ túi, đổi tay liên tục, dùng nghỉ hoặc nhờ người mang.

→ Tập mang vật nhẹ tăng dần; không tự thử vật nặng nếu có bệnh tim/đau lưng.

05

Việc nhà tốn sức & lâu hơn bất thường

Quét nhà, nấu ăn, thay ga giường phải nghỉ nhiều lần – giảm “dự trữ sức”.

→ Giai đoạn vàng để can thiệp sớm. Tìm xem giới hạn do cơ, tim phổi hay đau.

06

Tập luyện đuối hơn, hồi phục chậm hơn

Cùng bài cũ nhưng nâng ít hơn, đi ngắn hơn, đau mỗi kéo dài nhiều ngày.

→ Giảm tải nếu quá sức nhưng đừng nghỉ dài. Kéo dài → kiểm tra dinh dưỡng & sức khỏe.

NHÓM B · CHÂN & CHUYỂN TƯ THẾ

07

Phải chống tay mới đứng dậy khỏi ghế

Từ ghế sofa/ghế ăn phải tì tay lên thành ghế, đùi hoặc bàn mới đứng lên.
→ Dấu hiệu điển hình của sức mạnh chân thấp – nên làm test đứng lên ghế.

08

Đứng lên – ngồi xuống ghế 5 lần thấy chậm/khó

Phải lấy đà, dừng giữa chừng, hoặc không làm đủ 5 lần.
→ Bài đo chuẩn về sức mạnh chân & thăng bằng (cách làm ở Phần 7).

09

Khó đứng dậy từ bồn cầu thấp hoặc mép giường

Phải bám tường, kéo tay vịn, hoặc cần người đỡ; tăng nguy cơ ngã đêm.
→ Lắp tay vịn để an toàn, nhưng song song phải tập lại sức chân.

10

Luôn tìm thang máy dù chỉ lên một tầng

Không nói “tôi yếu” nhưng hay né cầu thang, dốc, đường xa, chỗ đứng lâu.
→ Hỏi lý do né: đau, khó thở, sợ ngã hay chân nặng? Nếu chân yếu → bắt đầu tập.

11

Phải kéo người bằng tay vịn khi lên cầu thang

Tay kéo mạnh vào lan can, bước từng bậc một, chân run khi lên xuống.
→ Tập bước bậc thấp, đứng lên ngồi xuống, nâng gót – có điểm tựa, tăng dần.

12

Không còn ngồi xổm/đứng lên từ sàn như trước

Ngại ngồi chơi với cháu, làm vườn; phải bám đồ mới đứng lên.
→ Đừng tự thử nếu dễ ngã. Phục hồi theo bậc: ghế cao → chuẩn → thấp → sàn.

13

Khó bước vào/ra ô tô, bồn tắm, giường cao

Phải dùng tay nâng chân, xoay người nhiều lần, hoặc cần người đỡ.
→ Yếu hai bên tăng dần → kiểm tra mắt cơ; yếu một bên kèm đau/tê → khám thần kinh.

NHÓM C · ĐI BỘ, THĂNG BẰNG & TẾ NGÃ

14

Đi bộ chậm hơn người cùng tuổi

Hay bị tụt lại, người nhà phải đi chậm lại, qua đường không kịp đèn xanh.

→ Chỉ báo mạnh của suy giảm chức năng – nên đo (đi 6 mét) khi khám.

15

Bước ngắn dần, kéo lê chân, khó đổi hướng

Đi “lúp xúp”, chân không nhấc cao, quay người phải nhiều bước nhỏ.

→ Đừng quy mọi dáng đi lạ cho “tuổi già” – có kéo lê/run/cứng → khám thần kinh.

16

Không đi liên 400–500 m như trước

Đi đoạn ngắn đã phải ngồi nghỉ; tránh đi chợ. Vòng xoắn yếu → ít đi → yếu hơn.

→ Dừng vì đau ngực/khó thở/đau bắp chân → khám trước khi quy cho mất cơ.

17

Bắt đầu cần gậy, tay vịn hoặc người dìu

Chỉ yên tâm đi khi bám người nhà hoặc chống gậy, nhất là ngoài đường.

→ Đừng bỏ gậy để “tự luyện”. Dừng đúng để tránh ngã, song song phục hồi sức.

18

Đứng lên – đi – quay lại – ngồi xuống chậm/loạng choạng

Cả chuỗi động tác mất nhiều thời gian, hoặc phải chạm tay giữ thăng bằng.

→ Bài đo lão khoa (TUG); bất thường → đánh giá nguy cơ ngã, rà thuốc, thị lực.

19

Vấp, hụt chân, suýt ngã lặp lại

Hay vấp mép thảm, bậc cửa; mất thăng bằng khi quay người; phải vịn đồ.

→ Cảnh báo trước cú ngã thật – rà thuốc, sửa môi trường, tập sức mạnh & thăng bằng.

20

Đã ngã trong 12 tháng, hoặc sợ ngã đến mức ngại hoạt động

Sau ngã không dám đi xa, không dám tắm một mình, tránh cầu thang.

→ Ngã kèm bất tỉnh/đau ngực/yếu liệt/chấn thương đầu → CẤP CỨU.

NHÓM D · HÌNH THỂ, DINH DƯỠNG & KHỐI CƠ

21

Bắp chân nhỏ hơn bình thường

Bắp chân gầy rõ, ống quần rộng ra, số đo giảm theo thời gian.

→ “Đại diện thô” của khối cơ, dễ tự theo dõi. Nhỏ/giảm dần → kiểm tra sức mạnh.

22

“Test vòng ngón tay” lỏng

Hai ngón cái + trỏ tạo vòng quanh chỗ to nhất bắp chân; vòng **rộng hơn** bắp chân là xấu.

→ Cách tự kiểm rất đơn giản (AWGS 2025). Lỏng + yếu/sụt cân → đo lực bóp tay.

23

Đùi hoặc cánh tay mảnh đi rõ

Ảnh cũ tay chân đầy hơn; nay cơ đùi “xẹp”, mông lép, áo quần rộng phần tay chân.

→ Teo nhanh/một bên kèm đau/tê/giật cơ → khám thần kinh – cơ.

24

Sụt cân mà không ăn kiêng

Không kiêng gì nhưng cân giảm, quần áo rộng, mặt và tay chân hóp đi.

→ Có thể là tín hiệu suy dinh dưỡng/bệnh mạn/ung thư – đừng chỉ uống đạm rồi bỏ qua.

25

Vòng bụng tăng nhưng tay chân nhỏ & yếu

Cân nặng bình thường/tăng, bụng to, nhưng chân yếu, tay chân không săn.

→ “Béo phì mất cơ”, dễ bỏ sót. Tránh nhịn ăn cấp tốc; giảm mỡ chậm + đủ đạm.

NHÓM E · THUỐC ĐO GIÚP BẠN CHẮC CHẮN

Đây là các công cụ bác sĩ dùng để xác nhận. Bạn không cần nhớ con số – chỉ cần biết chúng tồn tại và hỏi bác sĩ khi đi khám.

26

Bảng câu hỏi SARC-F ≥ 4 điểm

5 câu nhanh về sức mạnh, đi bộ, đứng dậy, leo cầu thang, té ngã (có ở Phần 7).

→ ≥ 4 điểm là dương tính cần kiểm tra (người ≥ 65). Điểm thấp không loại trừ.

27

SARC-F + vòng bắp chân (SARC-CalF) ≥ 11

SARC-F cộng điểm đo bắp chân để “bắt ca” tốt hơn.

→ Dương tính → là lý do đánh giá sức mạnh & khối cơ, không phải kết luận bệnh.

28

Lực bóp tay dưới ngưỡng theo tuổi – giới

Đo bằng lực kế – bằng chứng khách quan của sức mạnh thấp.

→ Lực thấp đã đủ gọi “có khả năng mất cơ” và nên can thiệp ngay (ngưỡng ở Phụ lục).

29

Khối lượng cơ thấp trên máy đo (DXA/BIA)

Máy đo thành phần cơ thể; thường không có triệu chứng riêng.

→ Khối cơ thấp + sức mạnh thấp = xác nhận sarcopenia (AWGS 2025).

30

Mất tự lập sau nằm viện, ốm nặng hoặc đợt bệnh mạn

Sau viêm phổi, phẫu thuật, suy tim, COVID-19, nằm giường lâu – không về mức cũ.

→ Bất động làm mất cơ rất nhanh. Đừng chờ “tự khỏe” – phục hồi sớm, có giám sát.

TỰ KIỂM TẠI NHÀ

Tự kiểm tra trong 5 phút

Mục tiêu không phải tự chẩn đoán, mà để biết **có nên đưa người thân đi khám hay không**.

Bước 1 – Trả lời 5 câu

- 1 6–12 tháng qua có thấy yếu đi rõ, làm việc thường ngày khó hơn?
- 2 Có sụt cân ngoài ý muốn, ăn kém, hoặc vừa nằm viện/nằm giường lâu?
- 3 Có ngã, suýt ngã, hoặc phải dùng gậy/người dìu?
- 4 Có khó đứng dậy khỏi ghế, leo cầu thang, hay đi chậm hơn trước?
- 5 Có bệnh mạn (tim, phổi, thận, tiểu đường, ung thư) hoặc thuốc nguy cơ?



Có từ một câu “có” rõ ràng là đủ lý do để đi kiểm tra.

Bước 2 – Hai bài tự kiểm an toàn (bỏ qua nếu dễ ngã)



Test vòng ngón tay

Vòng hai ngón quanh chỗ to nhất bắp chân.
Lỏng = tín hiệu cần chú ý.



Đứng lên ghế

Ngồi ghế chắc, khoanh tay, đứng lên–ngồi xuống. **Phải chống tay = chân yếu.**



Nếu bạn chỉ làm một việc: in Phiếu sàng lọc 5 phút (Phần 7) cho cha mẹ, tick rồi mang đi

khám.
Nội dung mang tính giáo dục sức khỏe – không nhằm chẩn đoán, điều trị hay thay thế tư vấn y khoa. Hãy tham khảo bác sĩ trước khi thay đổi chế độ tập luyện hoặc ăn uống.

ĐI KHÁM & AN TOÀN

Khi nào đi khám & bác sĩ đo gì

Nên chủ động đi khám khi có dấu hiệu  bất kỳ, hoặc một cụm dấu hiệu  đang nặng dần.



1. Sức mạnh

Đo lực bóp tay bằng lực kế (vài giây mỗi tay). Bước **phát hiện sớm**.



2. Khối lượng cơ

Đo bằng máy DXA hoặc BIA (không đau). Bước **xác nhận**.



3. Chức năng

Đi bộ ngắn, đứng lên ngồi xuống ghế. Xem bệnh ảnh hưởng cuộc sống tới đâu.



Nguyên tắc: Đo **sức mạnh** để phát hiện sớm · đo **khối cơ** để xác nhận · đo **chức năng** để biết can thiệp có hiệu quả không.

Khi mất cơ là dấu hiệu của một bệnh khác

Đừng vội cho rằng mọi yếu đuối đều là “do tuổi”. Mất cơ đôi khi là phần nổi của một vấn đề lớn hơn (thiếu máu, tuyến giáp, tim, thần kinh, ung thư...).



DẤU HIỆU ĐỎ – đi khám/cấp cứu NGAY: yếu đột ngột · yếu một bên · nói khó/méo miệng · khó thở hoặc nuốt nghẹn mới xuất hiện · đau ngực · ngất · nước tiểu sẫm sau đau cơ · sốt kèm yếu nhanh · tự nhiên không đứng/đi được · ngã chấn thương đầu. **Đây không phải “mất cơ do tuổi”.**

HÀNH ĐỘNG

Kế hoạch giữ cơ 12 tuần

Tập – ăn – chữa nguyên nhân – đo lại. Tập tại nhà chỉ với ghế và dây kháng lực.

GIẢI ĐOẠN	MỤC TIÊU	TẬP	ĐO LẠI
Tuần 1–4 Nền tảng	Đúng kỹ thuật, 3 buổi/tuần	Sức nặng cơ thể + ghế	Tuần 0: đo mốc nền
Tuần 5–8 Tăng tải	Tăng dần hiệp & kháng lực	Dây kháng lực, bước bậc	Tuần 4–8: theo dõi
Tuần 9–12 Duy trì	Tự tin tập, đưa vào đời sống	Bài đầy đủ + thử thách	Tuần 12: so kết quả

Tập kháng lực (nền tảng)

- ✓ Đứng lên ghế, ngồi xổm vào ghế, bước bậc thấp
- ✓ Đẩy tường, kéo dây, nâng gót, mang vật nhẹ
- ✓ 1–2 hiệp × 8–12 lần; ≥2 buổi/tuần
- ✓ Còn dư 2–3 lần thì dừng – không tập kiệt sức

Đạm & năng lượng

- ✓ ~1,0–1,2 g đạm/kg/ngày (cá thể hóa)
- ✓ Chia đều 3 bữa, đừng dồn buổi tối
- ✓ Mỗi bữa 1 nguồn đạm: trứng, cá, thịt nạc, sữa, đậu
- ✓ Đủ năng lượng; bệnh thận/gan/tim → hỏi bác sĩ



Chữa nguyên nhân: kiểm soát đau để vận động được · rà thuốc gây buồn ngủ/chán ăn · tối ưu bệnh nền (tiểu đường, tim, phổi, thận) · phục hồi sớm sau nằm viện.



Mục tiêu đúng: không phải con số đẹp trên máy đo, mà là **đứng dậy dễ hơn, đi nhanh hơn, ít ngã hơn, tự làm được nhiều việc hơn.**

BIỂU MẪU

In & dùng tại nhà

Bảng SARC-F (tiếng Việt)

CÂU HỎI	0 ĐIỂM	1 ĐIỂM	2 ĐIỂM
Mang/nâng vật ~4–5 kg	Không khó	Khó một phần	Rất khó / không làm được
Đi bộ qua phòng	Không khó	Khó một phần	Rất khó / cần trợ giúp
Đứng dậy khỏi ghế/giường	Không khó	Khó một phần	Rất khó / cần trợ giúp
Leo ~10 bậc cầu thang	Không khó	Khó một phần	Rất khó / không làm được
Số lần ngã trong năm qua	Không	1–3 lần	≥4 lần



Tổng ≥4 điểm: dương tính cần đi kiểm tra (người ≥65). Bản này để giáo dục & gợi ý.



Phiếu sàng lọc 5 phút

- ✓ Yếu đi / giảm chức năng trong 6–12 tháng
- ✓ Sụt cân ngoài ý muốn / ăn kém
- ✓ Ngã hoặc suýt ngã lặp lại
- ✓ Sau nằm viện chưa về mức cũ
- ✓ Bệnh mạn nguy cơ cao (tim, COPD, tiểu đường, thận, ung thư)
- ✓ Bắp chân nhỏ / test vòng ngón tay lỏng
- ✓ Đứng lên ghế phải chống tay / đi chậm hơn



Cách đo nhanh

- ✓ **Vòng bắp chân:** đo chỗ to nhất, chân thả lỏng, thước không siết
- ✓ **Test ghế 5 lần:** ghế cao ~43–45cm, khoanh tay, đứng-ngồi 5 lần
- ✓ Dừng ngay nếu đau ngực, chóng mặt, mất thăng bằng
- ✓ Lần sau đo cùng cách để so sánh

BƯỚC TIẾP THEO

Biết 30 dấu hiệu mới là **một nửa**

Nửa còn lại là **làm gì với nó** – và bạn không cần làm một mình. Đây là 3 cách Bác sĩ Chúc có thể đồng hành cùng bạn.



Học miễn phí

Theo dõi drchuc.com, Fanpage, YouTube “Bác Sĩ Chúc” & podcast “Sống Trưởng Thọ”.



Tư vấn & đo sức khỏe cơ

Nhắn Zalo **0947578088** để được hướng dẫn bước kiểm tra phù hợp.



Chương trình 12 tuần

Đang xây dựng – nhấn Zalo để nhận thông báo ngay khi mở đợt đầu tiên.

 drchuc.com

 **Zalo 0947578088**

[Facebook /bschuc](https://facebook.com/bschuc)

[YouTube @DrChuc](https://youtube.com/DrChuc)

“Muốn đi xa trong tuổi già, hãy xây đôi chân đủ mạnh từ hôm nay.” Và hôm nay có thể bắt đầu bằng một tin nhắn.

Nội dung mang tính giáo dục sức khỏe, không thay thế thăm khám và chẩn đoán. Tổng hợp từ AWGS 2025, EWGSOP2, ESPEN, WHO – chỉnh lý cho người Việt.



Bác sĩ Nguyễn Xuân Chúc

DÀNH CHO NHÂN VIÊN Y TẾ

Ngưỡng AWGS 2025 & Tài liệu

Cần đồng thời **sức mạnh cơ thấp + khối lượng cơ thấp** để xác nhận sarcopenia. Sức mạnh thấp đơn độc = “possible sarcopenia” → đủ để khởi động can thiệp.

PHÉP ĐO	NAM 50–64	NỮ 50–64	≥65 (NAM/NỮ)
Lực bóp tay (kg)	<34	<20	<28 / <18
DXA ASM (kg/m ²)	<7,2	<5,5	<7,0 / <5,4
BIA ASM (kg/m ²)	<7,6	<5,7	<7,0 / <5,7
Tốc độ đi 6 m (m/s)	<1,2	<1,2	<1,0
Đứng lên ghế 5 lần (giây)	≥10	≥10	≥12
Vòng bắp chân ≥65 (cm)	–	–	Nam <34 / Nữ <33
SARC-F / SARC-CalF	≥4 / ≥11	≥4 / ≥11	≥4 / ≥11



Nhóm 50–64: công cụ tự sàng lọc chưa đủ xác lập → đo trực tiếp lực bóp tay (± DXA/BIA) khi có lo ngại. Không trộn tiêu chuẩn EWGSOP2 và AWGS 2025; ghi rõ phiên bản, thiết bị, ngưỡng.

Tài liệu tham khảo

1. Chen LK et al. AWGS 2025 Consensus Update. *Nature Aging*. 2025;5:2164–2175.

2. Cruz-Jentoft AJ et al. EWGSOP2. *Age Ageing*. 2019;48(1):16–31.

3. Dent E et al. ICFSR Guidelines. *J Nutr Health Aging*. 2018;22:1148–1161.

4. Chen LK et al. AWGS 2019. *JAMDA*. 2020;21:300–307.

5. Lim WS et al. Singapore CPG Sarcopenia. *J Frailty Aging*. 2022;11:348–369.

6. Kirk B et al. GLIS definition. *Age Ageing*. 2024.

7. Malmstrom TK et al. SARC-F. *JCSM*. 2016;7:28–36. tập luyện hoặc

8. Barbosa-Silva TG et al. SARC-CalF. *JAMDA*. 2016;17:1136–

10. Volkert D et al. ESPEN geriatrics. *Clin Nutr*. 2022;41:958–989.

11. WHO. Physical Activity Guidelines. 2020.

12. Bauer J et al. PROT-AGE. *JAMDA*. 2013;14:542–559.

13. Whaikid P, Piaseu N. Protein + resistance meta-analysis. *Epidemiol Health*. 2024.

14. Cruz-Jentoft AJ, Sayer AA. Sarcopenia. *Lancet*. 2019;393:2636–2646.

15. Zhang S et al. Muscle function vs lean mass. *JNHA*. 2024;28:100403.

16. Chen LK et al. Normative muscle health. *JCSM*. 2025;16:e13731.

Nội dung mang tính giáo dục sức khỏe – không nhằm chẩn đoán, điều trị hay thay thế tư vấn y khoa. Hãy tham khảo bác sĩ trước khi thay đổi chế độ